جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : ليلى عبدالفتاح محمد سعدني

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الوراق **العنوان :** ....

رقم البطاقة : 28008162102245 **رقم التليفون :** 01114636978 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 16-08-1980**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ---

خطة العلاج : ---

المستشفي : --**قسم :** ---

جهة العلاج : ---**نفقات :** --

ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: ليلى عبدالفتاح محمد سعدني
National ID: 28008162102245

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

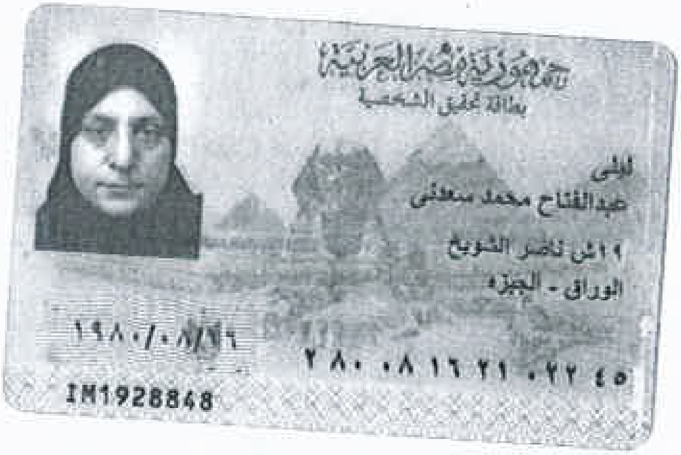
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

لبنى
عبدالفتاح محمد سعفنى
١٩ش ناصر الشويخ
الوراق - الجيزه

١٩٨٠/٠٨/١٦

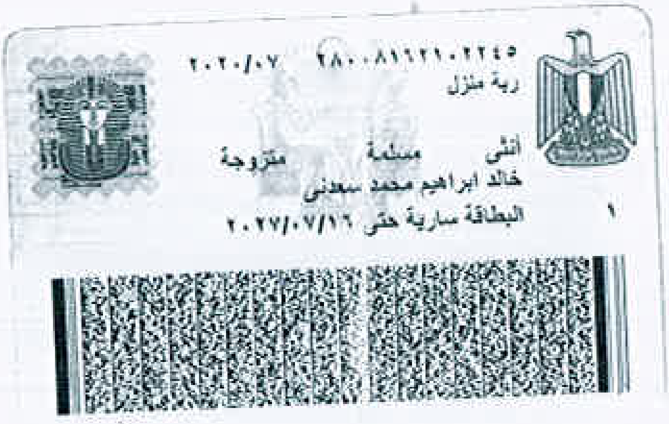
٢٨٠٠٨١٦٢١٠٢٢٤٥

IM1928848

٨/٨

١٢٥٠٠

National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



٢٠٢٠/٠٧ ٢٨٠٠٨١٤٢١٠٢٢٤٥

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة

خالد ابراهيم محمد سعدنى

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٧/١٦

National ID · Back

[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: ليلى عبد الفتاح محمد سعدنى **MR. :** 1789	GUSTAVE ROUSSY

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		**رقم طبي:**	

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

7/1/2026 PT ON HORMONAL TREATMENT SICE 3/2025 FEMARA CALCIUM 1*1*90. ONE ALPHA LAST ZOLADEX AT 27/12/2025

ER PR +VE, CT2 N1 M0, PT RECEIVED NACT - MRM 2024 - ADJ AI + SUPP TODAY FOR FEMARA + SUPP ZOLADEX ASAP PHARMACY

for femara + supp + zometa + zoladex if not received, after labs

prem rt breast cancer ct3 n1 mo idc 2 er8/8 pr8/8 her2-ve rec ac tct on 2/2025 yptis ypn0/2 rec zoladex and femara rth for zoladex femara to bring sm report cc vertigo and dysequilib for supp tt if not improoved for mri brain

تحريرا في ,

التاريخ : 19-09-2026

الوقت :

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : [illegible]
Sex Female
3- Medical number: 83117331
OU MRN 2141-2024
Patient Age : 45 Y

Family history +ve
Phone 01005064792
BMI
REASON OF MDT
Marital status
NRS Score
GROUP
Date of MDT 2025-03-01
Comorbidity -ve
Menopausal status
Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging : rt breast chronic inflammatory process rather than neoplastic BIRADS 4a	**Mets Workup :** free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IDC	8/8	8/8	0		4

T	N	M
3	1	0

Sonomammography

altered parenchyma showing surrounding dialtedducts filled the nipple with retained secretion , reaching the nipple via the dilated duct

PATIENT HISTORY

PATIENT STARTED 1ST CYCLE TAXOTERE
CESM ALMOST ALL RT BREAST IS INVOLVED, REACHING NIPPLE, PATH RIGHT AXILLA , LEFT AXILLA LEFT SUPRACLAV biopsy from lt axilla reactionary
patient received 4 cycles taxotere followed by ac then rt mastectomy
skin sparing mastectomy +SLNB+silicon implant:
few foci of ductal carcinoma insitu
free nipple disc, deep margin, LN 0/4
complete pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

FOR PORT +AI+ZOLDEX +ZOMETA/6M AFTER DENTAL

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	

inistry Of Health
lized Medical Centers
Salam Cancer Hospital
diology Department

طبية المتخصصة
ريم دار السلام
ة الأشعة

Total DLP (mGy.cm)

Patient Name: Lilli Abd Al Fattah Mohamed
Exam : C.T NECK WITH CONTRAST
Medical ID: 1788/2024

Date : 05/06/2024
Age : 30 Year(s)
Pat. ID: 54561

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS:

I Chest:

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross abnormalities.
- *Scanned lower neck cuts show prominent subcentimetric deep cervicxal lymph nodes, apprently bulky right parotid gland. For dedicated study assesssment.*

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenaution. No definite focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands, IVC and aorta.
- Under filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- IUCD is noted.
- L5 first degree lytic spondylolithesis.

Opinion:

- **Unremarkable CT chest study.**
- **Hepatomegaly.**

Dr. Ali Elsisy, M.Sc.
Dr. M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

[illegible]
[illegible] Medical Centers
[illegible] Cancer Hospital
[illegible] Department

Patient Name: Lili Abd al Fatah [illegible]	
Exam: CT NECK WITH CONTRAST	Date: 08/08/[illegible]
Medical ID: 1788/2024	Age: 30 Year(s)
	Pat. ID: 54661

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS:

I Chest:

- No sizable pulmonary ,nodules, masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross abnormalities.
- *Scanned lower neck cuts show prominent subcentimetric deep cervical lymph nodes, apprently bulky right parotid gland. For dedicated study assessment.*

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenuation. No definite focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands, IVC and aorta.
- Under filled urinary bladder showing no [illegible] outpouching
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- IUCD is noted.
- L5 first degree lytic spondylolithesis.

Opinion:

- Unremarkable CT chest, [illegible] hepatomegaly.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

atient Name : الأستاذة / ليلى عبدالفتاح محمد [illegible]
atient No. : 28008162102245
ath No. : 2014/24
ex : Female
ge : 43 Y
eferreing Doc. :

Request No. : 13005498
Request Date : 11/06/2024
Verification Date : 07/07/2024
Financial Category : أورام الثدي - مبكرة
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

nical Data: Right breast mass.
ture of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 11/6/2024.

chnique:
ections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) d stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and matoxylin as counter stain. The sections treated against:
R clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9), P63 clone (4A4), Calponin clone ?798Y).

sults:
?T (Positive control showed appropriate reactivity).
63 & Calponin: Negative in the invasive component.
R: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8 /8).
R: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8 /8).
er2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
i67: 4% nuclear reaction of tumor cells.

nclusion (Revised):
ght breast mass, Tru-cut biopsy:
nimally represented Invasive duct carcinoma, Grade II, in a background of fibrocystic changes

63 & Calponin: Negative in the invasive component.
R: Positive (score 8 / 8).
R: Positive (score 8 / 8).
er2: Negative (score 0).
i67: Positive in 4% of tumor cells.

Verified by :
DR Marina Nabil

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	:الأستاذة / ليلى عبدالفتاح محمد سعدني	Request No.	: 13008515
Patient No.	: 28008162102245	Request Date	: 01/02/2025
Path No.	:434/25	Verification Date	: 15/02/2025
Sex	: Female'	Financial Category	: [illegible]
Age	: 44 Y	Department	:OutPatient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed yo

Pathology Report

Clinical Data :
Right breast cancer post NACT

Nature of the specimen :
Right skin sparing mastectomy and sentenil lymph node biopsy specimens collected at 1/2/2025.

Gross Examination:
Two specimens were received:
-Right skin sparing mastectomy specimen measured 13x11x8 cm .
- Tumor extent : An ill defined rubbery greyish white tumor bed site
- Size: 7x6x2 cm
- Distance from margins:2 cm away from deep margin .
- Additional pathologic findings: Lateral side entangled two nodules measured 1x1 cm each.
-Sentenil lymph node biopsy specimen: Fibrofatty tissue piece measured 6x5 cm entangling 2 nodules up to 2x1x0.5 cm .
- Frozen section:
-Free SLNs (0/2).
- Gross key:
1-9) Tumor bed site.
10) Nipple disc.
11) Deep margin.
12) Sentenil nodes.
13) Entangled nodes.
Gross was done by Dr. Menan Hossam.

Microscopic examination:
- Few foci of ductal carcinoma insitu.

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]